

TEMA 2.8 • GINECOLOGÍA

Quiste y Absceso de Glándula de Bartolino

PERFIL EUNACOM 2.01.1.073

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Quiste y Absceso de Glándula de Bartolino

Comparación de las 3 Patologías

TABLA 2.8.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS			
	QUISTE DE BARTOLINO	ABSCESO DE BARTOLINO	FORÚNCULO PERIGENITAL
Causa	Obstrucción de la glándula	Infección glándula (ETS: gonorrea, Chlamydia)	Foliculitis por S. aureus
Ubicación	Medial al labio menor	Medial al labio menor (igual)	Lateral al labio mayor (zona pilosa)
Inflamación	Sin signos inflamatorios	Con signos inflamatorios (eritema, dolor, calor)	Con signos inflamatorios
Diagnóstico	Clínico	Clínico	Clínico
Tratamiento	Observación (o cirugía si grande/sintomático)	Drenaje quirúrgico + ATB amplio espectro	Observación; drenaje si grande; ATB anti-estafilocócico

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Diferencia clave: Misma ubicación (medial al labio menor) entre quiste y absceso. El absceso tiene signos inflamatorios + causa infecciosa (ETS). El forúnculo está **lateral** (donde hay pelos).

1. Quiste de Bartolino

Causa: Obstrucción del conducto de la glándula de Bartolino → acumulación de moco.

Clínica: Aumento de volumen en zona medial al labio menor, sin inflamación. Puede haber leve dolor si está muy tenso.

- **Tratamiento:**
- **Observación** (la mayoría)
- Si grande, sintomático o se complica: **drenaje quirúrgico** ± marsupialización

2. Absceso de Bartolino

Causa: Infección de la glándula o quiste. Principal: **gonorrea y Chlamydia** (ETS). También: Gram negativos, anaerobios.

Clínica: Aumento de volumen + **eritema** + **dolor intenso** (misma ubicación que el quiste).

- **Tratamiento:**
- **Drenaje quirúrgico** (siempre)
- ATB de amplio espectro con **cobertura para gonorrea + Chlamydia**:
- - Ej.: Ceftriaxona + doxiciclina + clindamicina
- Manejo completo de ETS: estudio de otras ETS (VIH, VDRL), educación, tratar pareja

3. Forúnculo Perigenital

Causa: Infección del folículo piloso por **S. aureus** (igual que cualquier furúnculo).

Ubicación: **Lateral a los labios mayores** (zona con folículos pilosos).

Importancia: No confundirlo con absceso de Bartolino — el agente y el antibiótico son distintos.

- **Tratamiento:**
- Pequeño: observación (drenaje espontáneo)
- Grande/abscedado: **drenaje quirúrgico** + ATB anti-estafilocócico VO:
- - Cloxacilina, flucloxacilina, cefalexina, o amoxicilina/ácido clavulánico
- - Alergia a betalactámicos: clindamicina

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Respecto a Quiste y Absceso de Glándula de Bartolino, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Quiste y Absceso de Glándula de Bartolino. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Comparación de las 3 Patologías
- 1. Quiste de Bartolino
- 2. Absceso de Bartolino
- 3. Forúnculo Perigenital
- Forúnculo Perigenital
- Medial al labio menor
- Si grande, sintomático o se complica:

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (QUISTE Y ABSCESO DE GLÁNDULA DE BARTOLINO)**PREGUNTA 1**

Respecto a Quiste y Absceso de Glándula de Bartolino, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A)** El diagnóstico de Quiste y Absceso de Glándula de Bartolino se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Quiste y Absceso de Glándula de Bartolino debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Quiste y Absceso de Glándula de Bartolino requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Quiste y Absceso de Glándula de Bartolino es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Quiste y Absceso de Glándula de Bartolino no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Quiste y Absceso de Glándula de Bartolino?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Quiste y Absceso de Glándula de Bartolino. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: QUISTE Y ABSCESO DE GLÁNDULA DE BARTOLINO

:::tip Diferencia clave: Misma ubicación (medial al labio menor) entre quiste y absceso. El absceso tiene signos inflamatorios + causa infecciosa (ETS). El forúnculo está lateral (donde hay pelos). ::: Clínica: Aumento de volumen en zona medial al labio menor, sin inflamación. Puede haber leve dolor si está muy tenso. Causa: Infección de la glándula o quiste. Principal: gonorrea y Chlamydia (ETS). También: Gram negativos, anaerobios.